Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Viamão

Rua Bento Gonçalves, 90, 2º Andar do Prédio Anexo - Bairro: Centro - CEP: 94415700 - Fone: (51) 3098-5599 - Balcão Virtual (51) 99586-1221 - Email: frviamao3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001089-88.2023.8.21.0039/RS

AUTOR: VENILDA GOMES DE MOURA
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: MUNICÍPIO DE VIAMÃO / RS

SENTENÇA

Vistos.

VENILDA GOMES DE MOURA ajuizou ação de obrigação de fazer em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MUNICÍPIO DE VIAMÃO / RS**, partes qualificadas nos autos. Disse ter sido diagnosticada com "Adenocarcinoma de cólon – CID 10 C 18.8, metastático (pulmonar)", necessitando do uso da medicação Bevacizumabe (Avastin) 5mg/kg 300mg pelo peso atual (60kg), a cada 14 dias. Afirmou ter buscado fornceimento administrativo, sendo informada que o medicamento não constava na lista básica de medicamentos. Discorreu sobre o custo do tratamento e sobre o risco à saúde. Pugnou pela concessão da tutela de urgência para determinar a concessão da tutela de urgência, para o fim de que seja concedida a medicação Bevacizumabe (Avastin) 5mg/kg - 300mg pelo peso atual (60kg), a cada 14 dias, ou o valor correspondente em dinheiro. Requereu a procedência da ação para confirmar a medida liminar. Rogou pela concessão da AJG. Juntou documentos.

A gratuidade de justiça e a medida liminar foram deferidas (evento 3, DESPADEC1).

Intimado, o Ministério Público opinou pela inclusão da União no feito e pela remessa dos autos à Justiça Federal (evento 13, PROMOÇÃO1).

Posteriormente, o Ministério Público apresentou manifestação pela não intervenção (evento 66, PROMOÇÃO1).

O Município de Viamão apresentou contestação (evento 72, CONT2). Preliminarmente, arguiu incompetência do juízo. Apresentou chamamento ao processo e denunciação da lide. Afastou a responsabilidade pelo custeio do fármaco. Requereu a improcedência da ação. Apresentou documentos.

O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL também apresentou contestação (evento 78, CONT1). Teceu considerações sobre a prescrição do medicamento pelo nome comercial. Argumentou sobre a política nacional de prevenção e tratamento antineoplásico no âmbito do SUS. Apontou a competência da União. Pleiteou a improcedência do feito. Acostou documentos.

Instadas as partes sobre a provas a produzir (evento 87, DESPADEC1), o Estado requereu a elaboração de Nota Tecnica via E-NatJus (evento 93, PET1).

Deferida a prova postulada (evento 119, DESPADEC1), a Nota Técnica foi acostada no evento 139, TRASLADO1.

Após manifestação das partes, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação em que a autora pretende a condenação dos demandados ao fornecimento de tratamento medicamentoso para tratamento que moléstia que a acomete.

Inicialmente, como será visto a seguir, a responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e Municípios ao fornecimento do tratamento de saúde é solidária.

> *RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DIREITO EVIDENCIADO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município, uma vez que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde. 2. Destarte, diante da solidariedade constitucionalmente prevista dos entes públicos para fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Piratini para fornecer o medicamento pleiteado. 3. Sentença de procedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009875568, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 22-03-2021)*

Ademais, a divisão administrativa das competências no âmbito do SUS não é oponível ao particular, devendo ser resolvida regressivamente entre os entes federados, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria e reafirmar sua jurisprudência no RE nº 855.178/SE (Tema 793).

Por conseguinte, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e indefiro o pedido de chamamento ao processo/ denunciação da lide da União, afastando a incompetência arguida.

No mérito, em atenção ao art. 23, II, da Constituição Federal e o art. 241 da Constituição Estadual, evidente a responsabilidade integral e conjunta de cada ente federado à prestação de saúde aos indivíduos.

A responsabilidade a que se refere, por evidente, é solidária e, observando o princípio da vedação do retrocesso, não pode ser afastada por normas de hierarquia inferior, isto é, se a Constituição estabelece o dever do Estado, leia-se Estado, União e Município, de prestar saúde aos seus cidadãos, os mesmos não podem dispor em regras ordinárias de forma a restringir tal direito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

> *APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INCLUSÃO DE MEDICAMENTO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. MERA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DO ESTADO. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO AO FADEP. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 1. Não há falar em sentença extra petita, uma vez que, em se tratando de direito à saúde, é assente a jurisprudência deste Tribunal acerca da possibilidade de inclusão de medicamentos ao longo da lide, uma vez que o bem almejado é o tratamento para a patologia apresentada e não o fármaco em si. Na hipótese, houve substituição do medicamento requerido, a fim de adequar o tratamento ao quadro clínico do autor, o que não implica alteração do pedido contido da petição inicial. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos. Assim, em se tratando de obrigação solidária, a satisfação imediata da pretensão pode ser exigida de qualquer um dos demandados de forma integral. Eventual ressarcimento entre os entes públicos deverá se dar na esfera administrativa ou em ação própria para tanto, a fim de oportunizar a ampla defesa e o contraditório. 3. Possível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FADEP, pois quanto a ele não se opera o instituto da confusão. Inteligência da Súmula 421 do STJ. 4. Honorários reduzidos para R$ 400,00, a fim de adequá-los ao caso em concreto e aos precedentes desta Câmara. APELO DO ESTADO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70084366434, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 24-09-2020)*

A Constituição Federal estabelece em vários dispositivos o dever do Estado, expressão que inclui de forma solidária Estados, Municípios e a União, de garantir aos indivíduos o direito à saúde física e mental.

Neste sentido, prevê o art. 196 da Carta Magna:

> *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".*

Já o art. 198 prevê a existência do Sistema Único de Saúde, o qual tem como diretriz o atendimento integral, competindo-lhe, nos termos do art. 200, I: "*controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesses para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos"*. Tal dever é também estabelecido no art. 243, X, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul.

Tratam-se de normas que, ao fixar o direito fundamental dos indivíduos à saúde, possuem eficácia plena. O fato da norma constante do art. 196 referir-se às políticas econômicas e sociais de governo não torna a sua eficácia limitada ou contida, pois todos os direitos fundamentais assegurados constitucionalmente possuem eficácia plena e imediata. Tal entendimento decorre da interpretação sistemática da Constituição, considerando os parágrafos primeiro e segundo do seu art. 5°, os quais reconhecem a existência de direitos fundamentais esparsos na Carta Magna e determinam a aplicação imediata das normas que expressem garantias e direitos fundamentais.

De igual forma, a Lei nº 8.080/90 estabeleceu a responsabilidade dos entes federados em prover as condições necessárias ao pleno exercício da saúde como direito fundamental, determinando as regras de organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde.

Trata-se, portanto, de garantir o direito à vida digna da autora, posto no art. 1º, III, da Constituição Federal, termos em que Ingo Wolfgang Sarlet bem elucida a noção de eficácia fática do direito social à saúde perante as limitações impostas pelo ente público:

> *"Embora tenhamos que reconhecer a existência destes limites fáticos (reserva do possível) e jurídicos (reserva parlamentar em matéria orçamentária) implicam certa relativização no âmbito da eficácia e efetividade dos direitos sociais prestacionais, que, de resto, acabam conflitando entre si, quando se considera que os recursos públicos deverão ser distribuídos para atendimento de todos os direitos fundamentais básicos, sustentamos o entendimento, que aqui vai apresentado de modo resumido, no sentido de que sempre onde nos encontramos diante de prestações de cunho emergencial, cujo indeferimento acarretaria o comprometimento irreversível ou mesmo o sacrifício de outros bens essenciais, notadamente – em se cuidando da saúde – da própria vida, integridade física e dignidade humana, haveremos de reconhecer um direito subjetivo particular à prestação reclamada em Juízo. Tal argumento cresce em relevância em se tendo em conta que a nossa ordem constitucional (acertadamente, diga-se de passagem) veda expressamente a pena de morte, a tortura e a imposição de penas desumanas e degradantes mesmo aos condenados pro crime hediondo, razão pela qual não se poderá sustentar – pena de ofensa aos mais elementares requisitos da razoabilidade e o próprio senso de justiça – que, com base numa alegada (e mesmo comprovada) insuficiência de recursos – se acabe virtualmente condenando à morte a pessoa cujo único crime foi o de ser vítima de um dano à saúde e não ter condições de arcar com o custo do tratamento". (in Algumas Considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na constituição de 1988, Revista Diálogo Jurídico nº 10, Salvador, 2002, p. 13).*

Ultrapassada a discussão acerca da responsabilidade dos réus, resta analisar a necessidade da parte autora quanto ao tratamento requerido.

Os documentos acostados à exordial indicam a doença que acomete a demandante. Ocorre que a Nota Técnica emitida no evento 139, TRASLADO1, que uso como razão para decidir, se mostra não favorável à concessão deste, conforme segue:

Conclusão

Tecnologia: BEVACIZUMABE

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de carcinoma de cólon metastático em segunda linha
CONSIDERANDO a solicitação de Bevacizumabe a ser combinado com quimioterapia
CONSIDERANDO a aprovação e indicação de Bevacizumabe neste cenário, com ganho de sobrevida global.
CONSIDERANDO que a CONITEC/PCDT emitiu parecer desfavorável em relação a incorporação de Bevacizumab ao SUS
CONCLUI-SE desfavoravelmente ao provimento da presente solicitação tendo em vista a manifestação negativa da CONITEC, em consonância com o tema 1234 do STF, ainda que possam existir elementos que sugiram algum potencial benefício em situações clínicas similares.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida

Destaco que, apresentado tal parecer, deveria a parte autora ter trazido elementos a rebatê-lo. No entanto, não foram acostados ao autos documentação contendo dados clínicos relevantes que permitam avaliar a demanda pleiteada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n.º 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º106), assentou os seguintes requisitos para que seja concedida a prestação jurisdicional vindicada:

> *i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
>
> *ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
>
> *iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.*

Sobre o tema, assim vem entendendo nosso Tribunal de Justiça:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MUNICÍPIO DE VACARIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PREGABALINA 100 MG E ESCITALOPRAM 10 MG. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REVOGADA. O STJ, ao decidir o REsp nº 1.657.156, em sede de recursos repetitivos (Tema 106), decisão esta ainda não transitada em julgado, firmou posição no sentido de ser obrigação do Poder Público fornecer medicamentos que estão fora da lista do Sistema Único de Saúde desde que a) haja laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficiência dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) que a parte tenha incapacidade financeira para seu custeio; e c) que tenha registro na ANVISA. No caso concreto, porém, o laudo carreado aos autos de fato não refere a ineficiência dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ademais, não há nos autos qualquer comprovante de renda ou documento obtido junto ao site da Receita Federal que demonstre a não apresentação de declaração de imposto de renda, não estando, pois, demonstrada a hipossuficiência econômica da agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 71009672445, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em: 04-03-2021)*
>
> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MEDICAMENTO. ELIQUIS. RUVASTATINA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INDEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ através do RESp nº 1.657.156-RJ, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, assentou requisitos para o fornecimento de medicamento s, no seguinte sentido: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". 2. No caso concreto, observa-se que a parte autora, ora agravante, possui renda de R$ 16.000,00, o que não preenche os critérios fixados pelo STJ no T ema Repetitivo nº 1 06, o que não caracteriza inviabilidade financeira para aquisição de fármacos cujo valor não ultrapassa R$ 300,00. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 71009426578, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 26-10-2020)*

Compulsando aos autos, tenho que a parte autora não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do STJ, impondo-se a improcedência do feito.

Isso posto, REVOGO a liminar e **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados por VENILDA GOMES DE MOURA em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e MUNICÍPIO DE VIAMÃO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despeas processuais, bem como a honorários advocatícios à parte ré, os quais fixo, para cada, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC. Suspensa a exigibilidade, pois beneficiária da gratuidade judiciária.

Em face da sistemática do Código de Processo Civil e da inexistência de juízo de admissibilidade, (art. 1010, § 3º do CPC), em caso de interposição de recurso de apelação, caso não seja intempestivo ou não haja o devido preparo, proceda-se na intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do RS.

Sentença publicada e registrada no sistema.

Transitada em julgado, dê-se baixa.

Documento assinado eletronicamente por **LINIANE MARIA MOG DA SILVA, Juíza de Direito**, em 14/01/2026, às 22:05:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10098281890v4** e o código CRC **121a604e**.